

6A. Codo: anamnesis dirigida

Localizar el máximo dolor y distinguir carga tendinosa, nervio cubital, articulación y rotura traumática.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele por fuera al agarrar, levantar una taza o extender la muñeca?	Epicondialgia lateral.	Reduce extensor común como generador principal.	Palpación epicóndilo, Cozen, Mill y Maudsley.
¿El dolor está más distal en el antebrazo y empeora al extender el tercer dedo?	Túnel radial/supinador frente a epicondialgia.	Reduce túnel radial.	Localización precisa, Maudsley y exploración radial/cervical.
¿Le duele por dentro al flexionar la muñeca, pronar o lanzar?	Flexor-pronador; en lanzador, valorar UCL.	Reduce patrón medial por carga.	Carga flexor-pronadora y moving valgus.
¿Tiene hormigueo en 4.º-5.º dedos, sobre todo con el codo flexionado o por la noche?	Neuropatía cubital en túnel cubital.	Reduce neuropatía cubital, no la excluye.	Tinel, flexión mantenida, fuerza intrínsecos y sensibilidad.
¿Notó chasquido, hematoma y pérdida de fuerza tras una carga súbita?	Rotura distal de bíceps o tríceps.	Reduce rotura completa aguda.	Hook test/defecto palpable, ecografía y Trauma preferente.
¿Tiene rigidez, derrame, bloqueo o dolor durante todo el arco?	OA, sinovitis o cuerpo libre.	Reduce generador articular difuso.	ROM, derrame, RX; si caliente/fiebre, descartar infección.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

El dolor lateral con agarre suele ser tendinoso, pero la localización distal, las parestesias o la pérdida brusca de fuerza obligan a cambiar el diagnóstico diferencial.

6B. Codo: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Cozen	Codo flexionado, antebrazo pronado; resistir extensión y desviación radial de muñeca con puño cerrado.	Dolor focal en epicóndilo lateral: apoya tendinopatía lateral.	Reduce epicondialgia, pero no excluye cuadros leves ni túnel radial.
Mill	Pronación, flexión de muñeca y extensión pasiva del codo para estirar extensores.	Dolor focal epicondíleo habitual: apoya origen extensor común.	No descarta tendinopatía; usar con Cozen y palpación.
Maudsley	Resistir extensión del tercer dedo con codo extendido y antebrazo pronado.	Dolor epicondíleo apoya extensores; dolor 3-5 cm distal puede orientar a túnel radial.	No excluye ninguna de ambas y no localiza por sí solo.
Moving valgus	Hombro abducido/rotado externamente; aplicar valgo mientras se extiende codo de flexión máxima a unos 30°.	Dolor medial entre 70°-120° o laxitud: sospechar UCL en lanzador.	Reduce lesión sintomática importante, pero no excluye parcial.
Tinel cubital	Percutir suavemente nervio cubital detrás del epicóndilo medial.	Parestesias habituales hacia 4.º-5.º dedos: apoya neuropatía cubital.	No la excluye por sensibilidad limitada.
Flexión mantenida	Mantener codo en flexión máxima, muñeca neutra, hasta 60 s; puede añadirse presión cubital.	Reproduce parestesias cubitales: aumenta sospecha de túnel cubital.	No excluye; completar fuerza intrínsecos, sensibilidad y subluxación dinámica.
Hook test	Codo 90°, antebrazo supinado; intentar enganchar con el índice el tendón distal del bíceps desde lateral.	No se palpa/engancha cordón: alta sospecha de rotura completa distal.	Tendón palpable reduce rotura completa, pero no excluye parcial.

SÍNTESIS CLÍNICA

Epicondialgia se apoya en dolor focal reproducido con carga, no en imagen aislada. Parestesias o debilidad obligan a explorar nervio cubital, radial y cuello. Hook test anormal tras trauma requiere derivación preferente.

6C. Codo: ecografía, intervención y plan

Evitar infiltrar dentro del tendón o del nervio. La ecografía sirve para concordancia estructural y guía segura.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Origen extensor común	Patrón fibrilar, grosor y cortical del epicóndilo; sin rotura, calcificación ni Doppler patológico.
Origen flexor-pronador	Continuidad fibrilar y entesis medial; relación con UCL.
Bíceps distal / tríceps	Continuidad hasta inserción, sin defecto ni retracción; maniobra dinámica si precisa.
Nervio cubital	Área, fascículos, surco y estabilidad dinámica; sin aumento focal ni subluxación sintomática.
Recesos articulares / ligamentos	Sin derrame, sinovitis ni cuerpo libre; UCL y complejo lateral según ventana.

Escenario	Opción	Después / límite
Epicondialgia lateral	Educación y carga progresiva extensora; terapia manual como coadyuvante. ESWT en crónica seleccionada.	8-12 semanas antes de declarar fracaso; el corticoide puede aliviar pronto pero empeorar recurrencia/resultado intermedio.
Tendinopatía persistente	Valorar procedimiento peritendinoso o PRP con decisión compartida; evidencia heterogénea.	Nunca prometer regeneración ni infiltrar intratendinoso; cirugía excepcional.
Dolor articular concordante	Infiltración intraarticular ecoguiada diagnóstica/terapéutica en OA o sinovitis seleccionada.	Si aspiración: analizar ante sospecha de infección/cristales.
Neuropatía cubital	Modificación postural, férula nocturna y neurodinamia; bloqueo perineural solo en casos seleccionados.	Déficit/atrofia, EMG grave o fracaso → cirugía; evitar lesión intraneural.

MENSAJE AL PACIENTE

El tendón necesita recuperar capacidad de carga. El alivio pasivo puede ayudar, pero la mejoría duradera depende de progresar fuerza y tolerancia sin picos bruscos.

6D. Codo: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Epicondilalgia	Diclofenaco gel 11,6 mg/g; 2-4 g, 3-4 veces/día.	7-14 días como apoyo al programa de carga.
Brote intenso	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250 mg/12 h si es seguro.	3-5 días; evitar prolongar en tendinopatía.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Neuropatía cubital	No hay AINE o neuromodulador de rutina que corrija compresión; analgesia según fenotipo y férula postural.	Revisar fuerza/sensibilidad en 4-6 semanas o antes si progresa.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Intraarticular	Betametasona depot 0,5-1 mL o triamcinolona 10-20 mg + lidocaína 1%.	Total 2-3 mL; solo generador articular concordante.
Bloqueo cubital	Lidocaína 1% o ropivacaína 0,2%; sin corticoide de rutina.	2-4 mL perineural; visualizar nervio y evitar intraneural.
Epicondíleo diagnóstico	Lidocaína 1% peritendinosa, sin corticoide.	0,5-1 mL en plano superficial; interpretar con tarea de agarre.
PRP peritendinoso	PRP autólogo según sistema; no mezclar con anestésico local o corticoide.	2-3 mL; evidencia heterogénea y decisión compartida.

REHABILITACIÓN

Carga progresiva de extensores/flexores, agarre y cadena proximal durante 8-12 semanas; 4-6 sesiones para enseñar progresión.

EVITAR

Corticoide intratendinoso, múltiples infiltraciones epicondíleas, punción intraneural o demorar derivación ante rotura distal del bíceps o atrofia cubital.